【临床护理】
※外科护理

心脏移植患者手术决策困境的现象学研究

谭雯渲[1,2],张容[3],张立力[2],王玮[4a],邵艳红[4b],方庆虹[2],朱瑾[2]
[1.江海职业技术学院 现代公共服务与管理学院,江苏 扬州 225101;2.南方医科大学护理学院,广东 广州 510515;
3.广东省第二荣军优抚医院 院长办公室,广东 佛山 510260;4.南方医科大学附属广东省人民医院(广东省医学科学院)
a.心脏移植与辅助外科;b.心外重症监护一科,广东 广州 510080]

[摘 要] 目的 探索心脏移植患者的手术决策困境,为临床实践者实施决策辅助支持提供参考。**方法** 2023 年 7-9 月,采用目的抽样法选取 18 例心脏移植患者进行访谈,采用解释现象学方法分析资料、提炼主题。**结果** 共提炼出 4 个主题:主体体验困境(身体状况不佳、情感混乱多元化、观念认知水平滞后)、信息支持困境(疾病知识缺乏、信息收集及筛选能力不足、医患沟通障碍)、伦理道德困境(家庭意见冲突、舆论压力大)、现实条件困境(经济条件有限、供体等待期漫长)。**结论** 心脏移植患者在手术决策上遭遇多重困境,包括身体和情感的双重挑战、信息获取与处理的障碍、伦理道德的困惑以及现实条件的限制。

[关键词] 心脏移植; 决策困境; 医患沟通; 决策辅助; 质性研究
[中图分类号] R473.54 **[文献标识码]** A **[DOI]** 10.16460/j.issn1008-9969.2025.03.069

Surgical decision dilemma among heart transplant patients: a phenomenological study

TAN Wen-xuan[1,2], ZHANG Rong[3], ZHANG Li-li[2], WANG Wei[4a], SHAO Yan-hong[4b], FANG Qing-hong[2], ZHU Jin[2]
*[1.School of Modern Public Service And Management, Jianghai Polytechnic College, Yangzhou 225101,China;
2.School of Nursing, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China; 3. Dean's Office, Guangdong Second Rongjun Youfu Hospital, Foshan 510260, China; 4a. Dept. of Heart Transplantation and Auxiliary Surgery; 4b. Intensive Care Unit I, Dept. of Cardiac Surgery, Guangdong Provincial People's Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou 510080, China]*

Abstract: Objective To explore the dilemmas of surgical decision among heart transplant patients and provide reference for clinical practitioners to implement decision assistance support. **Methods** From July to September in 2023, 18 heart transplant patients were selected by purpose sampling for interviews. Interpretive phenomenological analysis was used to analyze the data and extract themes. **Results** Four themes were extracted: subject experience dilemma (poor physical condition, affective disorder and pluralism, and poor cognition and conception), information support dilemma (lack of disease knowledge, poor information collection and screening ability, and doctor-patient communication barriers), ethical and moral dilemma (conflict of family opinions, and great pressure from public opinion), practical condition dilemma (poor economic conditions, and long waiting period for donors). **Conclusion** Surgical decision-making for heart transplant patients is accompanied by multiple dilemmas, including physical and emotional challenges, information acquisition and processing barriers, ethical confusion, and practical constraints.

Key words: heart transplantation; decision dilemma; doctor-patient communication; decision aid; qualitative research

随着医疗技术的迅速发展、医保制度改革不断深化、脑死亡立法以及公众对脑死亡观念的改变,心脏移植手术量在国内逐年增加[1]。心脏移植(heart transplantation,HTx)主要是针对晚期充血性心力衰竭和严重冠状动脉疾病进行的外科手术[2]。虽然心脏移植能够改善患者的生活功能与质量,但其后续所面临的挑战不容小觑,包括免疫抑制治疗、感染风险、移植物排斥及精神健康问题,严重影响生活质量[3]。不仅如此,患者还需面对个人压力,如生活自由度的限制、预期寿命的不确定性、婚姻生活不和谐、定期检查的不便、经济负担以及社会环境对新器官的过度关注等。这些因素致使患者陷入手术决策困境,无法作出决策而延误手术或治疗。目前,国内外心脏移植方面研究多偏向临床实践与管理,尚缺乏对心脏移植患者决策困境的关注[4]。因此,本研究旨在从患者角度深入了解决策困境体验,为制定个性化的决策辅助方案提供依据。

1 对象与方法

1.1 *研究对象* 采用目的抽样,选取 2023 年 7—9 月入住广东省某三级甲等医院心脏移植与辅助外科的患者进行半结构访谈。纳入标准:(1)符合心脏移植手术指征[5];(2)未确定是否接受手术;(3)年龄≥18 岁;(4)自愿参与本研究。排除标准:(1)具有精神

[收稿日期] 2024-09-10
[基金项目] 2023 年广东省医学科研基金项目(A2023007)
[作者简介] 谭雯渲(1999-),女,江苏扬州人,硕士,助教。
[通信作者] 张容(1973-),女,四川宜宾人,硕士,主任护师。E-mail:1344192002@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

疾病史;(2)重要器官功能严重损害。样本量以信息饱和为准,最终纳入受访者共18例,以P1~P18编号,其一般资料见表1。本研究已通过广东省人民医院伦理委员会审批(批号:KY-Z-2022-302-02)。

表1 受访谈心脏移植患者的一般资料(n=18)

编号	性别	年龄	婚姻	学历	居住地	职业	疾病诊断
P1	男	43	已婚	高中	城市	公务员	扩张型心肌病
P2	女	49	已婚	高中	城市	会计	重症心肌炎
P3	男	56	已婚	初中	农村	自由职业	缺血性心肌病
P4	男	29	已婚	本科	城市	程序员	扩张型心肌病
P5	男	58	已婚	高中	城市	事业单位	扩张型心肌病
P6	女	23	未婚	本科	农村	教师	心脏肿物
P7	男	64	已婚	初中	农村	退休	扩张型心肌病
P8	男	59	已婚	高中	农村	公务员	缺血性心肌病
P9	男	51	已婚	高中	城市	老板	心脏肿物
P10	男	22	未婚	本科	城市	学生	扩张型心肌病
P11	男	51	已婚	初中	城市	老板	缺血性心肌病
P12	女	19	未婚	本科	城市	学生	扩张型心肌病
P13	男	57	已婚	高中	城市	事业单位	急性心肌梗死
P14	男	21	未婚	本科	城市	学生	扩张型心肌病
P15	男	18	未婚	高中	农村	学生	扩张型心肌病
P16	男	20	未婚	本科	城市	学生	致心律失常右室心肌病
P17	男	50	已婚	本科	城市	教师	缺血性心肌病
P18	男	67	已婚	初中	农村	退休	扩张型心肌病

1.2 研究方法

1.2.1 制定访谈提纲 本研究团队成员包括心脏移植护理专家1名、心脏移植专科护士2名、心脏移植医生1名、护理学硕士研究生3名。通过文献回顾与小组讨论,围绕“心脏移植患者手术决策困境”初步拟定访谈提纲,随后以3例患者的预访谈反馈为基础进行细化与优化,最终形成访谈提纲如下:(1)能否分享您对心脏移植手术的认识与看法?(2)您认为患病后面临的治疗选择有哪些?(3)您能具体阐述一下做决定过程嘛?(4)您在决策过程中,遇到过哪些困难,产生了哪些影响?(5)您认为什么因素导致心脏移植手术决策的困难性?(6)您认为采取哪些措施能有助于更好地面对或解决手术决策困境?

1.2.2 资料收集方法 采用解释现象学分析[6]方法开展研究,遵循现象学、诠释学、特则取向的理论原则,关注受访者个体经验及其本质进行探究。在访谈前,研究者向受访者说明研究目标与方法,签署知情同意书,并承诺以编码保护姓名隐私,确立信任。访谈安排在心脏移植与辅助外科的专用谈话室,以面对面的形式进行,每次持续30~45 min,过程中进行录音与现场记录,包括受访者的表情和肢体语言。

1.2.3 资料分析与质量控制 在访谈结束24 h内,将访谈录音转录为文字,由访谈者与另一名研究者反复阅读并整理,最后向受访者反馈。2名研究者严格按照解释现象学分析[6]方法要求进行独立资料分析,主要为6个步骤:(1)反复阅读转录文本,对资料产生整体感;(2)初步注释与评析,标记有意义的陈述;(3)使用短语或句子对资料进行初步编码,提炼概括性主题概念;(4)将初步编码的主题进行归类,寻找主题间关联,将相关子主题归到抽象的大类主题之下,完成一个受访者数据的开放式编码;(5)着手下一个个案分析,重复第一到第四步的过程,直至完成所有数据的主题分析;(6)对比各个案例中出现的共同主题和特性主题,寻找个案间主题的关联性,并进行记录、整理和归类,形成最终主题。资料分析阶段2名研究者悬置自身观点,分别独自研读文本,逐句分析含义并提炼主题;意见分歧时,研究小组共同讨论完成;资料分析完成后与受访者确认最终主题,确保研究真实性。本研究累计访谈18名患者,累计访谈时间658 min,转录文字82 108字,编码139个。经过资料分析,形成4个主题,10个亚主题。

2 结果

2.1 主题1:主体体验困境

2.1.1 身体状况不佳 多数患者入院时存在胸闷、呼吸急促、疲劳、胃肠道功能紊乱等不适,影响患者参与手术决策。2名访谈对象经历过多次电除颤,病情严重随时可能发生生命危险,影响决策时机。P2:“我病情越来越重,每天都很疲惫,这2 d更是一直拉肚子,很难受,没有精力再去多了解手术。”P13:“我那时情况十分危急,突发心梗,前后经历十几次电除颤,那种感觉(痛苦表情)...后面怎么治的也不知道了,就前段时间刚ECMO撤机,现这会又各种指标不好被送到这个科,不想管了真不想管了,让医生和我老婆操这个心吧。”P14:“之前做过‘ICD植

中国知网 https://www.cnki.net

入术',但心脏仍时不时各种不舒服,前段时间还经历了放电,实在是太痛苦了,医生说是手术能改善,本想多了解治疗方案,但我现在这个身体状态,真的是什么都不想管,实属心有余而力不足。"

2.1.2　情感混乱多元化　患者情绪混乱呈现多元化,因手术带来新机会能重新开始生活而感到希望与兴奋,因担心手术的成功、术后康复和药物不良反应而感到恐惧与焦虑,因长期生病就医而感到抑郁与内疚,这些复杂情绪干扰患者理性思考,增加决策困难[7]。P4:"自从生病以来,妻子一边工作一边照顾我,她以前多漂亮啊,现在因为我忙的整天灰头土脸(叹气),是我拖累她,有的时候真的想一死了之,但又想到我 2 个刚出生不久的儿子,真的舍不得,还想看他们长大。"P16:"真的好害怕,这么大手术,万一下不来手术台怎么办,术后并发症又那么多,远期存活率又不高,但不做手术身体只会越来越差(叹气)。"P18:"现在心脏那么紧张,好多年轻的孩子也等待供体,他们的人生才刚刚开始,我一个 67 岁老头,按道理也活够本了,还跟他们抢的话蛮愧疚的。"

2.1.3　观念认知水平滞后　部分患者仍寄希望于其他替代方案如内科治疗、微创等,企图避免心脏移植,甚至存在侥幸心理,易出现决策意向延迟的情况。P5:"不到最后一步,真的不想做,我还想去北京再找专家看看,能不开刀肯定是最好的。"P6:"我就是活动后心慌气促的厉害,来检查就直接跟我说心脏上长了肿瘤,从来没听过心脏还能长肿瘤的,还只能移植才能活,我才刚大学毕业找到工作,一旦接受这个手术以后的生活是黑暗的,我得去更好的医院再看看。"P17:"虽然我的心功能下降了,但是我觉得还没有严重到需要移植心脏的程度,移植是很可怕的。"

2.2　主题 2:信息支持困境

2.2.1　疾病知识缺乏　患者在缺乏对心脏移植手术及整体治疗方案的深入了解时,往往难以透彻理解治疗选择、手术风险和后果,对治疗前景产生不确定感,直接导致决策意识下降。P1:"我们那小地方哪听说过这种手术,咱也不懂那肯定就得听医生的,专业的人干专业的事,医生让我干啥就干啥。"P7:"我年纪大了,大脑反应迟钝理解能力差,每次医生说我都有好好听但都不是很懂,还得靠家人。"P8:"医生助理要我注意好多问题,当时好像都知道了,现在一想有很多不是很明白,你再给我讲一遍呗。"

2.2.2　信息收集及筛选能力不足　患者及家属出于对心脏移植手术的不了解,会多方面获取治疗方案的信息,但原发病的错综复杂和当今信息的众多杂乱,导致患者及家属获得真实正确的信息颇具困难,面对海量信息难以筛选和应用,致使决策质量下降。P9:"我咨询许多专业人士,希望了解是否适合进行心脏移植手术,心脏移植手术最好的医院是哪家,最在意的是术后生存率、生活质量如何。但因听到太多不同的回答,我感到不安,不确定是否接受手术。"P12:"网上充斥着心脏移植手术的虚假广告,还各不相同,我无法辨别真实情况和虚假信息,这让我感到非常困扰。"P16:"医生讲的和手机搜的不一样,也不知道该听谁的,不敢轻易做决定。"

2.2.3　医患沟通障碍　患者倾向于遵循医生的建议,信赖其专业知识以获得最优治疗方案的指导。但在实际就医过程中,医生的表情、语言和态度会使患者及家属陷入决策困境。P3:"医生很忙的,有的时候想多和医生聊聊,但是后面还排了好些个人。"P10:"当时医生也没有讲很多,就说我现在情况是需要心脏移植的,给我简单说一下,就让我回去等供体,到现在我都好懵。"P11:"医生说的很多信息都很笼统,像科学饮食、合理运动等,这说跟没说有什么区别,咱也不知道怎么吃叫科学,怎么动叫合理。"

2.3　主题 3:伦理道德困境

2.3.1　家庭意见冲突　在患者决定治疗方案时,家庭成员的观点具有关键性作用,但家庭成员之间的分歧可能会增加决策复杂性。P11:"我身体我了解,做移植手术是迟早的事,早做晚做都得做,但我老婆不愿意做这么大手术,说没到那一步还是要试试内科,我还是要听她的想法的。"P16:"虽然我个人对生死很淡然,且不愿意成为家庭的重担,但考虑到家人因我年纪尚轻而对手术充满希望,我最终选择尊重他们的愿望,准备接受手术。"P18:"一开始我是想做手术的,但家人一直不表态,其实我都懂,我也想明白了,一把年纪活得也够本了,治了以后还得花钱吃药还得有人一直照顾,我不想成为儿女负担。"

2.3.2　舆论压力大　家庭经济状况、疾病预后等客观因素是影响患者做决定的重要因素,但周围人的言论也会对决策的制订产生影响,从而导致患者陷入决策困境。P4:"生病住院花钱如流水,要是让别人知道我倾家荡产来治病会怎么想我,要是治不好,不但没给妻儿留点家产反倒是留下一屁股债(叹气)。"P7:"光凑齐手术费用就很难,术后长期服药定期复查都是钱,真的招架不住,但选择放弃的话,我不知道怎么和亲朋好友说。"P15:"做完手术后会有好大一条疤,同学们看到都不敢靠近我,把我当怪人看待

中国知网　https://www.cnki.net

怎么办。”

2.4 主题4:现实条件困境

2.4.1 经济条件有限 多数患者已经历长期的就医过程,手术费用及术后治疗花费使患者面临巨大的经济压力,医保报销范围窄、报销比例低、异地报销受限以及医保和商保之间的互补缺陷均会使患者陷入决策困境。P3:“对我们农村家庭而言,30万的移植费用简直就是天方夜谭,而这只是一个开端,后续还有一大笔花费。我又只有新农合医保,报销的比例也不高,还有很多自费项目,大部分都要自己承担。”P4:“听说手术后的长期治疗花费不低,我们夫妻俩工资不高,双方父母没有退休金更是无法提供金钱支援,哎。”P18:“这个病医保报销比例低,手术费用加上术后治疗花的钱可不是一点点,就算报完也是一笔不小的费用。”

2.4.2 供体等待期漫长 供与需的不平衡延长了心脏移植手术的等候期,加剧患者的焦虑和不确定性进而影响患者心理健康。部分患者等候期因病情危重,周而复始地处于“复发-治疗-复发”循环状态,身心俱疲,无力与命运抗争,也渐渐失去了对生的希望和信念[8]。P7:“等待供体期间反复就医几乎耗尽毕生积蓄,好害怕还没等到供体人就先没了,落得人财两失。”P14:“医生说有合适的心脏会随时与我联系,刚开始很会很激动,手机随身带,一到晚上还会紧张,就怕接不到医生电话。但到现在,说实话已经等了好几个月,越等下去看的也就越淡了,手术做不做都无所谓了。”

3 讨论

3.1 症状负担重和情感复杂性是心脏移植患者陷入决策困境的主要因素 本研究结果显示,原发疾病与长期治疗给心脏移植患者带来胸闷、呼吸急促、疲劳、胃肠道功能紊乱等症状负担,使患者决策时存在主体体验困境,影响患者参与手术决策。症状负担是机体正常功能改变时给机体造成的难以承受的负荷,代表患者经历的症状数量、频率和严重程度,呈现多维度、动态变化、可测量的特点,是决定生存质量的关键[9]。心脏移植患者症状负担重可能会减弱患者的身体耐受性,增加手术风险,使其更难以应对手术过程和术后康复。再者,心脏移植患者处于特殊决策情境之中,症状负担重、观念认知欠缺,加之对术后生存率及并发症的无法预料,致使其在决策中情绪混乱,参与决策意愿不高,出现决策延迟、逃避决策的情况,进而错过最佳治疗时机。心脏移植患者因手术带来新机会能重新开始生活而感到希望与兴奋,因担心手术的成功、术后康复和药物不良反应而感到恐惧与焦虑,因长期生病就医而感到抑郁与内疚,这些复杂情绪干扰患者理性思考,增加决策困难。深入分析上述内心矛盾的原因,主要与疾病冲击触发信息过载、对手术不确定性的担忧而产生未知的恐惧有关。因此,专业人员应加速探索心脏移植决策辅助系统的开发和应用,在最短时间内帮助患者思考手术的益处、风险和不确定性,减少心脏移植患者决策困境体验痛点,促进患者主动决策意愿和能力。

3.2 信息支持有限和医患沟通障碍是心脏移植患者陷入决策困境的重要因素 本研究发现,心脏移植患者出于对疾病知识的缺乏,会通过多种渠道收集信息,但在面临不同来源的信息时,甄别能力不足易被误导,导致做出错误的决策或出现盲从现象,这与Almgren等[10]研究结果一致。究其原因:一方面与信息过载和来源不一致有关,互联网上充斥着大量医学信息造成患者难以筛选出可信度高的信息,同时不同的信息源可能提供相互矛盾的建议,导致患者难以辨别可靠信息;另一方面与医学专业术语的复杂性有关,心脏移植知识涉及复杂的医学专业术语和概念,对患者而言是陌生的、难以理解的,使患者更容易被误导。为此,医护人员应加强疾病全程教育来改善患者的知识水平,可开展“线上+线下”多元化的心脏移植知识科普工作,以减少患者错误理解与认知偏差。此外,本研究还发现,心脏移植患者倾向于依赖专业人士的决策指导,但也会因医患间信息不对等、沟通过程理解偏差导致医患沟通障碍。在医患交流中,医生若未能以简洁清晰的措辞详尽阐释手术程序、潜在风险及术后生活变化,并未能妥善解答患者的疑问,则可能触发患者对信息透明度的质疑,由此产生认知上的缺漏。Vromans等[11]研究发现,低质量沟通影响患者决策过程,致使患者陷入决策困境之中。因此,医护人员需准确评估患者健康素养水平,基于自身临床经验和患者个人特点,运用通俗易懂的语言介绍治疗方案,具体剖析患者对疾病的理解程度、对手术风险及并发症的认知,提高患者决策的科学性。

3.3 家庭意见冲突和舆论压力大是心脏移植患者陷入决策困境的驱动因素 本研究中,访谈对象提出个人决策与家庭支持和周围人言论密切相关,均影响最终手术决策的制订。家庭成员及亲友的支持,在提供附加信息和情感慰藉方面发挥重要作用,能显著缓和患者的情绪波动[12]。心脏移植手术、术后管理等费用对于部分家庭来说是较大的负担,需要家

中国知网 https://www.cnki.net

庭在物质与精力上持续投入,且决策结果直接影响整个家庭结构和分工。1 项质性研究表明[13],家庭成员和同伴在决策过程的支持与共同参与带给心脏移植患者安全、温暖、舒适和归属感,他们的支撑使其在短时间内做出最佳决策,形成合理化预期并促进最好结局,这与 Tadros 等[14]研究结果一致。因此,医护人员在沟通时要理解每名家庭成员的态度及需求,为家庭成员参与医疗决策提供所需的信息支持。另一方面,在本研究中,部分心脏移植患者仍处于学习、工作的年龄,怀有重返学业或职场的强烈愿望,来自同学、同事和搭档等社交圈内的舆论压力,已成为心脏移植患者陷入决策困境的驱动因素。同时,社会限制、工作维持、雇主提供的便利等亦是心脏移植患者在手术决策时必须仔细权衡和深思熟虑的重要考量因素。因此,着眼于患者的家庭与社会网络,扩展社会支持的维度,为其提供家庭成员沟通技巧、重返社会方案等,提升决策体验和满意度。

3.4　经济条件有限和供体等待期漫长是心脏移植患者陷入决策困境的关键因素　访谈结果显示,现实条件是影响心脏移植患者决策的关键因素,家庭经济条件或医疗保险政策与供体等待期漫长的矛盾使患者产生决策困境。究其原因,(1)心脏移植手术的本质为一项成本高昂的医疗行为,涵盖手术费、医疗费、住院费用等。对经济条件受限的患者而言,家庭承担高额医疗费用的能力有限,致使患者陷入经济压力和决策困境;(2)后续医疗开支显著,包括但不限于终身服用免疫抑制剂等药物,以及进行定期医疗检查与随访,这些长期财务负担可能对患者的经济状况构成深远影响。另一个层面上,处于等待期的心脏移植患者经历了曲折的医疗决策过程,漫长求医路已然耗尽积蓄,经济拮据使患者迷茫,出现回避、退缩等心理,从而无法理性参与医疗决策。董芸等[15]调查发现,心脏移植患者术前心理压力水平普遍较高,可能出现恐惧、紧张、焦虑等心理状态,而医疗费用是关键影响因素。因此,国家需加快医药卫生体制改革,加大报销比例,完善医疗保险支付标准[16];在医疗机构管理层次上,深化临床路径执行力的构建,以最小化医嘱变异率,实现医疗费用的有效管控,从根本上缓解心脏移植患者所面临的医疗经济负担问题。

[参　考　文　献]

[1] 陈良万,李虔桢,戴小福,等. 心脏移植的发展现状和新挑战[J].器官移植,2023,14(1):31-41. DOI:10.3969/j.issn.1674-7445.2023.01.004.

[2] Khush KK, Cherikh WS, Chambers DC, et al. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation:thirty-fifth adult heart transplantation report-2018; focus theme: multi-organ transplantation[J].J Heart Lung Transplant, 2018, 37(10): 1155-1168. DOI:10.1016/j.healun.2018.07.022.

[3] Fatma C,Cigdem C,Emine C,et al. Life experiences of adult heart transplant recipients:a new life,challenges,and coping[J]. Qual Life Res,2021,30(6):1619-1627. DOI:10.1007/s11136-021-02763-y.

[4] 弓宸,顾明,史润泽,等.基于共词战略坐标图的心脏移植护理研究热点分析[J].护理学杂志,2019,34(23):24-28. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2019.23.024.

[5] Velleca A, Shullo MA, Dhital K, et al. The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) guidelines for the care of heart transplant recipients[J]. J Heart Lung Transplant,2023,42(5):e1-e141. DOI:10.1016/j.healun.2022.10.015.

[6] 侯力琪,唐信峰,何丽,等.解释现象学分析在中国的运用:系统评价及指南[J].心理科学进展,2019,27(11):1826-1841. DOI: 10.3724/SP.J.1042.2019.01826.

[7] 娄宇枫,王莉,何雪花,等.心脏移植受者心理健康状况的研究进展[J].护理研究,2023,37(8):1431-1434.DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2023.08.021.

[8] 郑静静,郑亚华,张黎. 肝移植受者移植等候期的心理体验[J].中国护理管理,2022,22(1):57-62. DOI:10.3969/j.issn.1672-1756.2022.01.013.

[9] 宋丽君. 基于患者报告结局的肺癌患者症状负担和症状群研究[D].北京:中国中医科学院,2023.DOI:10.27658/d.cnki.gzzyy.2022.000100.

[10] Almgren M, Lundqvist P, Lennerling A, et al. Self-efficacy, recovery and psychological wellbeing one to five years after heart transplantation: a Swedish cross-sectional study[J]. Eur J Cardiovasc Nurs, 2021, 20(1):34-39. DOI:10.1177/1474515120927121.

[11] Vromans R, Tenfelde K, Pauws S, et al. Assessing the quality and communicative aspects of patient decision aids for early-stage breast cancer treatment: a systematic review[J].Breast Cancer Res Treat, 2019, 178(1):1-15. DOI:10.1007/s10549-019-05351-4.

[12] 李嘉琪,叶向红,左俊焘,等.终末期患者营养支持决策过程质性研究的 Meta 整合[J].护理学报,2024,31(2):53-58. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2024.02.053.

[13] Lannon H, Code J, Poole J, et al. Patients and caregivers perspectives of the connection between home and the transplant journey[J]. Heart Lung, 2023,57:265-270. DOI:10.1016/j.hrtlng.2022.10.008.

[14] Tadros HJ, Rawlinson AR, Gupta D. Family functioning in the families of paediatric heart transplant recipients prior to outpatient visits and procedures[J]. Cardiol Young, 2021, 31(3):501-503. DOI:10.1017/S1047951120004217.

[15] 董芸,李燕君,曾珠,等.社会支持和心理干预在心脏移植病人等待期护理中的应用[J].护理研究,2019,33(13):2217-2221. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2019.013.007.

[16] 吕璐洋,王华芬,卢芳燕,等.肝移植患儿家庭照顾者出院准备体验的质性研究[J].护理学报,2023,30(9):13-17.DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2023.09.013.

[本文编辑:谢文鸿]

中国知网　https://www.cnki.net